EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 83891
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 08-05-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS HERNAN LARA ECHEVERRIA			RUN	: 9.407.888-1
F.Nac	: 24-07-1962	Edad	: 61 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: HUENUTIL DE LA CABRERIA CMC. 7-635800-00			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: DIPRECA	Teléfono	: 422540719		
Fecha Ingreso	: 2024-04-24	Fecha Egreso	: 08-05-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K74.6-OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-LRA Kdigo 3 no oligurica multifactorial Resuelta
-Encefalopatia Hepatica G1
-ACLF/CLIFF 54 Pt (37.8% mortalidad al mes)
-Cirrosis OH activo Child C / MeldNA 35 (66% mortaliad a 3 meses)
-Hiponatremia moderada resuelta
-Hiperkalemia moderada resuelta
-Obesidad Morbida / SAHOS
-FA s TACO.
-hipertension arterial

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K70.3-CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. G93.4-ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E66-OBESIDAD. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. G47.3-APNEA DEL SUENO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 62 años con antecedentes de HTA, Obesidad Mórbida, ICC, FA sin TACO, DHC por OH - Child Pugh C, con hospitalizaciones previas por descompensacion de su DHC, con antecedentes de mala red de apoyo y falta de adherencia a Tto. Ingresa el 24/04/24 derivado desde APS por compromiso del estado general de 4 dias de evolucion, depocisiones escasas tras suspension de tratamiento cronico, encefalopatico, hiperkalemico, hiponatremico, hiperamonemico, glasgow 10 puntos. Exámenes de ingreso reportan glicemia 93, crea 1,7; ac urico 6,4; bili tot/dir 6.2/1.41; LDH 296; lactato 2; BUN 51, uremia 109; amonio 107; Na/K/Cl 127/6.3/99; Hb/Hcto 16.1/45.9; Gb 8.2; plaq 116000; segment 50%; INR 1,97; se ingresa a sala medicina para observación y manejo. paciente evoluciona torpidamente durante sus primeros dias de hospitalizacion, persiste encefalopatico, soporoso, inestable hemodinamicamente con tendencia a bradicardia, con escasas depocisiones, edematoso, con laboratorios que reportan elevacion de creatinina llegando a 4.30 y trastorno hidroelectrolitico destacando hiponatremia (127) e hiperkalemia (5.9), icterico, se realiza ecografia abdominal el dia 04/05 que descarta evidencia de ascitis puncionable y litiasis biliar, se realiza TAC de encefalo sin hallazgos y tac de torax S/C sin hallazgos patologicos, se ajusta tratamiento manteniendo manejo de encefalopatia, y expansion de volumen con albumina + Solucion fisiologica y posterior terlipresina logrando

gran mejoría de creatinina y de kalemia llegando a rangos normales, paciente evoluciona con mejoria de funcion renal posterior a ajuste de tratamiento, menos encefalopatico que dias previos, Clínicamente estable. Afebri, sin conflicto infeccioso. Hemodinamia estable, normotenso. Sin conflicto ventilatorio, sin apoyo de O2. Vigil, obedece ordenes sencillas, sin agitación psicomotora, sin flapping, GCS 15 pts, movilizándose asistido sin incidentes. sin edema de extremidades, manteniendo Depocisiones diarias liquidas (1-2 /día), BH negativos, Buen control metabólico. alimentandose por SNG, Exámenes control 06/05 destacan resolucion de lesion renal aguda, Crea: 1,10 mg/dl | MDRD: 68,05 ml/min/1,73 m² | Uremia: 123 mg/dl | Amonio: 31,0 umol/L | Na: 136 mmol/L | K: 5,10 mmol/L | Cl: 107 mmol/L.
En condiciones de traslado (LUN 06/05/24) para continuar manejo de encefalopatia en hospital comunitario, EN PRIMERA INSTANCIA, PERO SIN CUPOS --> LUEGO SE EVALUA CASO CON TRABAJADORA SOCIAL Y HERMANO, Y SE DEFINE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA.

PLAN DE MANEJO:

HODOM 1 SEMANA APROX: MANEJO ENCEFALOPATIA, KINE, EVALUAR RETIRO SONDAS (NASOGASTRICA Y FOLEY)
CONTROL POST ALTA HODOM, 1 MES POLI MED INT HSC
CONTROL SOS VIA URGENCIA

INDICACIONES AL ALTA

1. -HODOM
2. -Reposo relativo asistido, Movilizar frecuente, Prevencion lesiones por presion,
3. -Alimentacion MIXTA, SI VIGILIA Y BIEN DESPIERTO: VO // SI ENCEFALOPATICO Y SIN COOPERAR: VIA SNG (segun educacion)
4. -Hidratacion 2000 cc al dia Via ORAL O SNG
5. -VVP (MANTENER PERMEABLE, PARA EVENTUAL NECESIDAD)
6. -LACTULOSA 45cc x VO O SNG cada 8 horas
7. -RIFAXIMINA 200Mg 2 comprimidos cada 8 horas por VO O SNG, suspender una vez estabilizado paciente, mantener solo lactulosa
8. -METOCLOPRAMIDA 10mg 1 comprimido cada 8 horas VO O SNG, suspender logrando 3 depocisiones en el dia
9. -BROMURO IPRATROPIO 2 Puff C/ 6 hrs con aerocamara, SOS si dificultad respiratoria
10. -TTOS CRONICOS:
11. CARVEDILOL 6,25MG 1 C/12 HRS VO
12. ESPIRONOLACTONA 25MG 4 C/12 HRS VO
13. OMEPRAZOL 20MG 1 AL DIA VO
14. .

EXÁMENES Y RESULTADOS

Crea: 1,10 mg/dl | MDRD: 68,05 ml/min/1,73 m² | Uremia: 123 mg/dl | Amonio: 31,0 umol/L | Na: 136 mmol/L | K: 5,10 mmol/L | Cl: 107 mmol/L.
Tac de cerebro: Sin alteraciones agudas
Tac de torax: Deficiente descenso diafragmático con adherencias pleurales basales y enfermedad bronquial crónica.
Eco abdominal: Ex limitado, se recomienda tac contrastado.

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO